TUBE DIGESTIF · DI-04

# Occlusion du grêle · sur bride

**WSES Bologne 2017**
scanner, signes de gravité, traitement non opératoire

**Imagerie (WSES Bologne 2017) :** le **scanner injecté** est l'examen de choix en cas de doute sur la cause ou de suspicion de contre-indication au traitement non opératoire ; il prédit la strangulation avec une exactitude d'environ 90 %. Le **produit de contraste hydrosoluble** oral a un intérêt diagnostique et thérapeutique : son arrivée dans le côlon sur un cliché à **24 h** prédit la résolution. La radiographie seule n'est pas recommandée pour le diagnostic ; échographie ou IRM si grossesse ou scanner indisponible.

## TROIS QUESTIONS AU SCANNER

### 1 · Occlusion mécanique ?

- Grêle dilaté **> 2,5 cm** en amont, grêle plat en aval
- **Zone de transition** : changement brutal de calibre
- Signe des fèces dans le grêle : oriente vers la transition
- Côlon peu aéré si occlusion complète

### 2 · Quelle cause ?

- Bride : angulation brutale sans masse, antécédent chirurgical
- Hernie pariétale ou interne, éventration
- Tumeur, invagination, Crohn, bézoard
- Iléus biliaire : pneumobilie + calcul ectopique

### 3 · Signes de gravité ?

- **Anse fermée** : anse en U ou en C, double bec, tourbillon, œdème mésentérique asymétrique
- **Ischémie** : paroi hypo-rehaussée, hyperdensité pariétale spontanée, contenu dense
- Pneumatose, aéroportie, perforation
- Liquide libre, œdème du mésentère

## ORIENTATION SELON LE SCANNER ET LA CLINIQUE

| SITUATION | CONDUITE HABITUELLE (WSES 2017) |
|---|---|
| **Pas de signe de gravité** | **Traitement non opératoire** : aspiration digestive, réhydratation, contraste hydrosoluble (50–150 mL, per os ou par la sonde) ; cliché de contrôle à 24 h |
| **Échec du traitement non opératoire** | Traitement non opératoire prolongé jusqu'à **72 h** en l'absence de signe de strangulation ; au-delà, sans résolution : chirurgie |
| **Péritonite, strangulation, ischémie** | **Chirurgie sans délai** ; une anse fermée est à haut risque d'ischémie |

Prédicteurs d'échec du traitement non opératoire et de chirurgie urgente (WSES) : liquide libre, œdème mésentérique, absence de signe des fèces, anse dévascularisée, associés aux vomissements, à une douleur intense, une défense et une hyperleucocytose.

## PIÈGES

### Lecture

- Lire les reconstructions coronales : anse en U, double bec
- Comparer la densité du contenu de l'anse suspecte à celle des anses d'amont
- Un iléus réflexe (sans transition) peut aussi donner un signe des fèces

### Contexte

- Chirurgie dans les 6 semaines, hernie irréductible : hors traitement non opératoire standard
- Absence d'antécédent chirurgical : chercher activement une hernie ou une tumeur
- Les brides ne sont pas visibles : diagnostic par élimination

## COMPTE RENDU

**Occlusion**
oui / non, complète ou non, niveau de la transition

**Cause**
bride probable, hernie, tumeur, autre

**Gravité**
anse fermée, ischémie, liquide, perforation

**Suivi**
contraste hydrosoluble : côlon atteint ou non à 24 h

TUBE DIGESTIF · DI-04

# Occlusion du grêle · sur bride (suite)

**WSES Bologne 2017**
scanner, signes de gravité, traitement non opératoire

## ATLAS VISUEL

**Occlusion du grêle : signes à chercher au scanner**




**Zone de transition**
grêle > 2,5 cm en amont

**Signe des fèces**
stase, oriente la transition

**Anse fermée**
en U ou en C, double bec

**Tourbillon**
mésentère et vaisseaux enroulés

**Ischémie**
paroi hypo-rehaussée, liquide

**Pneumatose**
± aéroportie : nécrose

Schémas simplifiés, non à l'échelle · gris = anses, noir = air

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Occlusion du grêle**
Radiopaedia · signes, causes
radiopaedia.org/articles/small-bowel-obstruction

**Anse fermée**
Radiopaedia · signes de strangulation
radiopaedia.org/articles/closed-loop-obstruction

**Signe des fèces**
Radiopaedia · intérêt et pièges
radiopaedia.org/articles/small-bowel-faeces-sign

**Anse fermée ischémique (cas)**
Radiopaedia · cas scanner
radiopaedia.org/cases/closed-loop-obstruction-18

**Occlusion intestinale**
Radiopaedia · démarche générale
radiopaedia.org/articles/bowel-obstruction

**WSES Bologne 2017**
PMC · texte intégral
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6006983/

**Sources :** ten Broek et al., Bologna guidelines ASBO 2017 (WJES 2018) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6006983/ · Radiopaedia – small bowel obstruction – radiopaedia.org/articles/small-bowel-obstruction · Radiopaedia – closed loop obstruction – radiopaedia.org/articles/closed-loop-obstruction